

ECCEMA

Samsara López Hernández, Raúl López Izquierdo.

INTRODUCCIÓN

El término eccema hace referencia a un patrón clínicopatológico de inflamación cutánea debido a múltiples causas, siendo la espongiosis la lesión histológica más característica.



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del eccema se basa en las manifestaciones clínicas características como son: el prurito que puede ser de intensidad variable y las lesiones eritematosas en la piel.

En función del tiempo de evolución, se distinguen tres fases sucesivas:

Eccema agudo: Comienza como un eritema y edema localizado en forma de máculas o pápulas con vesículas que suelen ser pequeñas y agrupadas. La rotura de éstas da lugar a un exudado que termina en la formación de una costra.

Eccema subagudo: Predominan las lesiones descamativas.

Eccema crónico: Liquenificación con engrosamiento de la piel, grietas, fisuras, alteraciones en la pigmentación y lesiones de rascado.

Debemos indagar en la anamnesis en los antecedentes personales y familiares del paciente, el tiempo de evolución y la extensión de las lesiones, las regiones afectadas, los antecedentes epidemiológicos (trabajo, deportes, mascotas, plantas) y en los tratamientos realizados previamente y su resultado en el caso de que los hubiese realizado.

Actualmente, se suelen clasificar los eccemas en base a su etiología:

Dermatitis numular: Afecta sobre todo a adultos de ambos sexos entre los 50-70 años y en meses invernales. Se trata de lesiones localizadas, con placas eritematodescamativas redondeadas afectando habitualmente en las piernas y brazos.

Dishidrosis: Aparece en personas con lavados frecuentes de manos. Consiste en vesículas y/o descamación en caras laterales de los dedos de manos y pies, muy pruriginosas.

Dermatitis atópica: Es una enfermedad inflamatoria y pruriginosa de la piel. Suele presentarse con mayor frecuencia en la población infantil aunque no es exclusiva. A menudo hay un aumento sérico de inmunoglobulina IgE y suele asociarse unos antecedentes personales y familiares de

atopia. En la edad adulta las lesiones predominan a nivel labial, periocular y perioral, cuello, flexuras y dorso de las manos. Suelen presentar xerosis, manchas descamadas eritematosas, pequeñas vesículas, excoriación, costras y, no infrecuentemente, impetiginización. El diagnóstico se basa en la clínica: picor, distribución típica según la edad, curso en brotes e historia familiar y personal de atopia (asma, rinitis, alergias).

Dermatitis seborreica: Manchas eritematosas con escamas finas de aspecto grasiento, habitualmente en región malar, frente, tórax y cuero cabelludo.

Eccema de contacto irritativo y eccema de contacto alérgico: Los agentes irritantes más frecuentes son los ácidos o álcalis fuertes y disolventes utilizados con frecuencia en la industria y por el ama de casa.

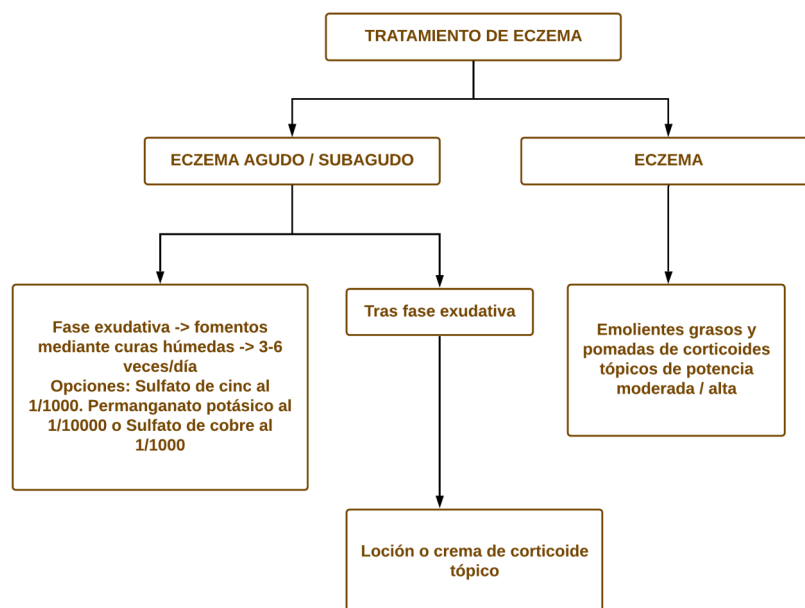
ECCEMA DE CONTACTO IRRITATIVO	ECCEMA DE CONTACTO ALÉRGICO
Mecanismo no inmunológico. Citotóxico directo	Mecanismo inmunológico. Reacción de hipersensibilidad tipo IV
Inicio en minutos/horas	Inicio en horas/días
Localizado sólo en la zona de contacto	Se extiende por la periferia. Puede generalizarse
Bordes bien definidos	Bordes imprecisos
Síntomas asociados: escozor, dolor, quemazón	
Influye el tiempo de contacto y la concentración del irritante	Depende del grado de sensibilización del paciente, con independencia de la concentración del agente
Agua, jabones, disolventes, saliva, orina, ácidos, bases	Metales, cosméticos, fármacos, adhesivos, resinas

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Medidas generales:

- Evitar cambios de temperatura bruscos.
- Evitar el estrés.
- Ducha diaria corta con agua fría. Jabón pH neutro. Secar con suavidad sin frotar.
- Usar ropa amplia y de algodón. Evitar la lana, eliminar etiquetas o costuras, utilizar detergentes suaves y evitar suavizantes.
- Aplicar diariamente crema hidratante tras la ducha y siempre que sea necesario. No usar durante el brote agudo ya que pueden empeorar el cuadro.
- Realizar un buen control del prurito: cortar bien las uñas, hidratación
- Evitar alimentos sólo si existe relación directa con los brotes (demostración clínica y analítica).

Tratamiento específico:



Tratamiento sistémico: en los casos más graves y extensos, pueden utilizarse:

- **Corticoides sistémicos.** Prednisona a 0,5-1mg/Kg/día.
- **Antihistamínicos por vía oral.** Bilastina 20mg 1 cada 24h o Cetirizina 10mg 1 cada 24h durante 7 días. Para aliviar el prurito, está contraindicada la vía tópica.
- **Ansiolíticos.** Se puede indicar el uso de ansiolíticos para disminuir la ansiedad y favorecer el sueño en algún paciente adulto.
- **Antibiótico.** En el caso de que sospechamos sobreinfección bacteriana habría que iniciar tratamiento con antibióticos que cubran tanto al *S. aureus* como el *Estreptococo betahemolítico* del grupo A tales como **Cloxacilina 500mg** 1 cada 6 horas durante 10 días o **Amoxicilina-clavulanico 875/125mg** 1 cada 8 h durante 10 días.

Criterios de derivación a Dermatología son:

- Lesiones generalizadas
- No respuesta a la terapia tópica.
- Sobreinfecciones graves o dudas diagnósticas.
- Dermatitis de contacto en relación con actividad laboral.
- Necesidad de pruebas de contacto.

BIBLIOGRAFÍA

- Lera Imbuluzqueta JM, Bernad Alonso I, Ivars Lleó M, España Alonso A. Dermatitis de contacto. *Medicine*. 2014;11(48): 2813-22.
- Infante Hernando ML, Serra Baldrich E. Tratamiento del eccema de manos. *Mas Dermatol*. 2012;17:22-25.
- Lim WH. Eccemas, fotodermatosis, enfermedades papuloescamosas (incluidas las fúngicas) y eritemas figurados. En: Goldman L, Schafel A. *Goldman-Cecil. Tratado de Medicina Interna*. 25ª Ed. Barcelona: Elsevier; 2016. p. 2662-2671.
- Bielsa Marsol I, Ferrándiz. *Dermatología Clínica*. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2014. p. 91-97.
- Senán Sanz MR, Casanova Seuma JM. *Dermatólogo. Eccemas*. AMF. 2012;(8):185-196.
- Garavís González JL, Ledesma Matín MC, de Unamuno Pérez P. Eccemas. *Semergen* 2005; 31(2):67-85.